

MAURICIO MENEZES MIACCE

SINTOMAS / QUEIXAS: Sonolência / Sudorese / Cefaleia /
 MEDICAMENTOS: Amilofon Puran 100 / Rivotril (10 gts)
 TU de parotida / Tumor (2013 TU) / Desvio de septo.
 HORA QUE DORME: 21:30 - 22:30 HORA QUE ACORDA: 5:50 / Diverticulite

BANHEIRO

1X

TIPO DE RESPIRAÇÃO

nasal

PRATICA EXERCICIO

Musculação / Bike

HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: N ALMOÇO: S LANCHE: N JANTAR: 19/5

IDADE:

PESO: 90

IAH: 91.3

MALLAMPATI:

SPO2: 48%

01/02 P= aut. 4-12 cmH₂O.

med. 88%.

23 Higienização OK

08/02 P= 9.2 cmH₂O. -

23

IAH= 3.4 e/ev

m. de uso: 8:30

Bem adaptado

fua.

11/04

P= 8.7 cmH₂O

Demonstrou elite

23

IAH= 2.7 e/ev

m. de uso: 8hr

fua.

21/11

P= 9.0 cmH₂O

23

m. de uso: 6h43'

Fuga = 7min.

IAH= 2.9 e/ev

fua claudie

13/05

P= 9.0 cmH₂O

24

IAH= 3.4 e/ev

M. de uso: 6hr

fua



Dr. Enio Narihiro Kokubu
CRM - 87265

OTORRINOLARINGOLOGIA

Clinica
Cirurgia

Mauricio Mendes
Miaçu

Exames
Audiológicos

Solicito a realização
para a adaptação
de Cpap

Inoplastia
Otoplastia

Alergose melh

Enio Narihiro Kokubu
Otorrinolaringologia
CRM 87265

251022

(12) 3911-1155 - Tel./Fax: 3913-5677

Rua Jorge Barbosa Moreira, 49 - Vl. Ema - São José dos Campos - SP - CEP 12243-070

Dr. José Maria Simões da Costa
Médico de Otorrinolaringologia
CRM 27127

Nome: MAURICIO MENEZES MIACCI
Data de Nascimento: 31-1-1977
IMC: 31,67
Sexo: Masculino
Data do exame: 27-09-2022

Peso: 97 kg
Altura: 1,75 m
Médico: DR. ENIO NARUHIRO KOKUBU
Medicamentos:
Histórico:

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 27-09-2022, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 515,0. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 2,0 e 94,0 minutos. O tempo total de sono foi de 443,5, eficiência de 86,1% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 1,8%; estágio N2: 75,1%; estágio N3: 4,2%; sono REM: 18,9%. O índice de despertares foi de 60,4/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 91,2/hora, sendo elas 27 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 491 hipopnéias. A SpO2 média foi de 78% e mínima de 48%, permanecendo 88,9% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 55 - 108 bpm e NREM de 55 - 100 bpm.

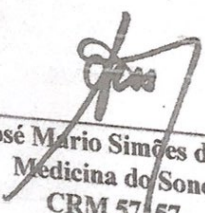
CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (10), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono preservada;
2. porcentagem do sono REM e do estágio N3 do sono NREM diminuída e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 91,2/hora;
4. houve dessaturação da oxihemoglobina (min. SaO2=48%);
5. latências para o sono normais;
6. aumento do número de despertares breves;
7. registro de ronco intenso durante o sono.

Exame evidenciando apneia obstrutiva do sono e dessaturação de graus acentuados.

IAH: 05-15 /hora leve.
IAH: 15-30 /hora moderada.
IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157